Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Cruz Alta

Rua Voluntários da Pátria, 714 - Bairro: Ludke - CEP: 98005-104 - Fone: (55) 3029-9957 - balcão virtual (55) 99688-3250 - Email: frcruzalta1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5004554-58.2024.8.21.0011/RS

AUTOR: GISELE DE FATIMA AGUIAR PEIXOTO
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

GISELE DE FÁTIMA AGUIAR PEIXOTO, ajuizou a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, todos qualificados. Aduziu, em síntese, que é acometida de "Carcinoma Ductal Infiltrante de Mama" (CID C50), sendo que em razão do estágio avançado da enfermidade, há risco de vida iminente, e que o tratamento da doença deve ser realizado com o fármaco KISQALI (RIBOCICLIBE) 200mg, na posologia de três cápsulas ao dia por 21 dias, com pausa de 7 dias, por tempo indeterminado. Destacou a inexistência de alternativas terapêuticas similares ou genéricas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que condições financeiras para arcar com o elevado custo do tratamento, estimado em R$ 204.739,92 anuais. Referiu que não obteve fornecimento do fármaco pela via administrativa. Pugnou, em tutela provisória de urgência, o imediato fornecimento do medicamento. Requereu a procedência da ação para condenar o requerido ao fornecimento do medicamento. Vindicou a gratuidade de justiça. Juntou documentos (evento 1).

Foi solicitado parecer técnico ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (evento 3).

Anexado parecer técnico (evento 5).

Recebida a inicial, foi concedida a gratuidade de justiça e deferido o pedido de tutela de urgência (evento 7).

O Estado do Rio Grande do Sul, citado, apresentou contestação com preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual. No mérito, reiterou a responsabilidade dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) e das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACONs) pela dispensação de medicamentos antineoplásicos, tendo em vista que o custeio é obrigação federal. Asseverou que a parte autora não comprovou a recusa de atendimento pelos centros de oncologia, destacando que o alto custo do fármaco é outra condição que impede sua dispensa e responsabilização de fornecimento pelo órgão estadual. Discorreu sobre o tema 6 do STF, bem como da denominação comum brasileira para dispensa do medicamento e, em caso de bloqueio de valores, a aplicação do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Requereu a improcedência da ação. Juntou documento (evento 19).

Houve réplica (evento 22).

A parte autora peticionou requerendo o bloqueio de valores (evento 24).

Acolhido o pedido, foi determinado o sequestro do montante necessário à aquisição do fármaco, oportunidade em que as partes foram intimadas para dizer sobre o interesse na produção de provas (evento 25).

Foram prestadas contas, informando a devolução do valor bloqueado, pois havia medicamento em estoque (evento 37).

Nada sendo requerido, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que as questões de fato e de direito estão suficientemente elucidadas pela prova documental produzida, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A preliminar de mérito da incompetência territorial absoluta, suscitada pelo requerido em contestação, não merece acolhimento, restando sedimentada a competência da Justiça Estadual para a análise do caso, conforme decidido no Agravo de Instrumento 51747669720248217000 (35.1):

> ***DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 793 E 1.234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.***
>
> ***I. CASO EM EXAME***
>
> *1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento Ribociclibe à autora, portadora de carcinoma ductal infiltrante de mama.*
>
> ***II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO***
>
> *2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda referente ao fornecimento de medicamento oncológico incorporado ao SUS, cujo valor anual é inferior a 210 salários-mínimos, ajuizada antes da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234 do STF; (ii) saber se é devida a remessa dos autos à Justiça Federal, com base*

nas recentes decisões do STF sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento Ribociclibe foi incorporado à política pública do SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 73, de 6 de dezembro de 2021, estando indicado para tratamento do câncer de mama avançado ou metastático, conforme assistência oncológica.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de fornecimento de medicamentos, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.

5. Posteriormente, no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), o STF modulou os efeitos para fixar a competência da Justiça Federal apenas para demandas ajuizadas após a publicação da ata do julgamento, relativas a medicamentos oncológicos incorporados ao SUS, cujo custo anual seja igual ou superior a 210 salários-mínimos.

6. No presente caso, o valor anual do tratamento é inferior a 210 salários-mínimos e a demanda foi ajuizada antes da publicação do resultado do julgamento, motivo pelo qual não há alteração de competência nem necessidade de inclusão da União no polo passivo, devendo o feito prosseguir perante a Justiça Estadual.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do STF, cancelou as teses fixadas no IAC 14 e reafirmou a vedação à suscitação de conflito de competência em processos anteriores ao marco fixado na modulação do Tema 1.234.

8. Prevalece, assim, a responsabilidade solidária do ente público demandado, sem necessidade de litisconsórcio passivo com a União ou remessa à Justiça Federal.

9. Precedentes deste Tribunal de Justiça ratificam a manutenção da competência da Justiça Estadual em hipóteses idênticas e o prosseguimento do feito contra o ente federativo estadual, mesmo em se tratando de medicamento oncológico incorporado ao SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento desprovido.

Dito isso, é fato incontroverso nos autos que a parte autora é acometida da doença narrada na inicial, restando apurar se o tratamento prescrito pelo médico assistente é adequado e quem é o ente federativo que deve alcançar o medicamento necessário ao tratamento.

A Constituição Federal, em seu artigo 196 e seguintes, evidencia que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado (aqui compreendido em sentido amplo como União, Estados, Distrito Federal e Municípios), que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, o direito à saúde enquadra-se como um direito fundamental do indivíduo, elencado dentro dos direitos sociais (art. 6º, *caput*, da CF), que merece proteção irrestrita dos poderes públicos, uma vez que indispensável à densificação do direito à vida e ao postulado da dignidade da pessoa humana.

Trata-se de um direito de eficácia imediata e aplicabilidade direta, dispensando qualquer providência legislativa ou administrativa para o reconhecimento de sua implementação, com fulcro no art. 5º, §1º, da CF.

O direito à saúde, mais especificamente o tema envolvendo o fornecimento de medicamentos, embora seja ampla e constitucionalmente assegurado, vem sendo objeto de decisões pelos Tribunais Superiores a fim de fixar balizas sobre as demandas judicias que envolvem que a questão.

Dentre os temas questionados envolvendo a matéria, está o da composição do polo passivo da ação e consequente juízo competente para apreciar a demanda, ponto que fora levantado pelo requerido em sua contestação.

Conforme se infere da nota técnica anexa aos autos, o Ribociclibe (Kisqali), buscado pela parte autora, encontra registro na ANVISA, mas não é incorporado em ato administrativo do SUS (evento 5.1).

Todavia, em consulta ao sítio da CONITEC, verifica-se que o fármaco foi recomendado à incorporação pelo Relatório 678[1], o que se perfectibilizou pela Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, senão vejamos (vide https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2021/20211207_portaria_73.pdf):

Ref.: 25000.112928/2021-08, 0023990518.

O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos arts. 20 e 23 do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde.

A incorporação do fármaco ao SUS, aliás, também foi objeto de expressa manifestação no julgamento do Agravo de Instrumento que conheceu da competência deste juízo para apreciar a lide (evento 33, DOC1).

Sendo assim, não se aplicam ao caso os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF, que se referem especificamente à *"concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde"*.

Por outro lado, o precedente vinculativo advindo da Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1.234), que tratou da legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal em ações que se discute sobre medicamentos registrados na ANVISA e incorporados ao SUS, deve servir de fundo para conhecer da matéria por este juízo.

Por meio das teses fixadas no Tema em questão e da homologação dos acordos interfederativos, a decisão visa a organizar e conferir maior segurança jurídica à judicialização da saúde, objetivando garantir o acesso aos medicamentos, otimizar os recursos públicos e promover a sustentabilidade do SUS.

Em julgamento de embargos de declaração opostos em face da referida decisão, o STF esclareceu que se tratando de ação que versar sobre medicamento oncológico incorporado, a competência para julgamento será da Justiça Federal somente quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos, vejamos:

> *O Tribunal, por unanimidade, 1) não conheceu dos embargos opostos pelos amici curiae e por Vinícius Aluísio de Moraes, como assistente, por ausência dos requisitos legais; 2) rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina,* ***mas os acolheu a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC;*** *e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico. Tudo nos termos do voto do Relator. O Ministro Luiz Fux acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 6.12.2024 a 13.12.2024. grifei.*

No mesmo sentido, são os precedentes do TJ/RS:

> *DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RIBOCICLIBE. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. CASO EM EXAME:1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ribociclibe 600mg, prescrito para tratamento de câncer de mama (CID C50.9) em estágio clínico IV, sob fundamento de não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico incorporado ao SUS; (ii) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, considerando o julgamento do Tema 1234 pelo STF. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. O medicamento Ribociclibe está incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, que incluiu a classe de inibidores de ciclinas para tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-.2. Conforme o julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234) e RE 1.366.243 ED pelo STF, a competência para julgamento de ações que envolvam medicamentos oncológicos incorporados ao SUS é da Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos.3. No caso concreto, o custo anual do tratamento é de R$ 297.347,76, valor inferior ao limite de 210 salários mínimos, o que mantém a competência da Justiça Estadual.4. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão presentes, pois a parte autora comprovou a necessidade do medicamento por meio de laudo médico que atesta a utilização prévia do arsenal terapêutico disponível no SUS, a urgência do tratamento para evitar a progressão da doença e o risco de óbito.5. A hipossuficiência da parte autora está demonstrada pela representação da Defensoria Pública, assim como o indeferimento administrativo do pedido de fornecimento do medicamento.6. A fixação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento da obrigação de fazer pela Fazenda Pública é medida cabível e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial, conforme entendimento do STJ no Tema 98 (REsp 1.474.665/RS). IV. DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso provido para determinar o fornecimento do medicamento Ribociclibe à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária.Tese de julgamento: 1. O fornecimento de medicamento oncológico incorporado ao SUS, cujo custo anual seja inferior a 210 salários mínimos, é de competência da Justiça Estadual e deve ser deferido em sede de tutela de urgência quando comprovada a necessidade do tratamento e a hipossuficiência do paciente. _____Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196; CPC/2015, arts. 300, 536, 537.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16-09-2024; STF, RE 566.471/RN, Tema 6; STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26-04-2017, Tema 98; TJRS, Agravo de Instrumento nº 51202482620258217000, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 17-07-2025.(Agravo de Instrumento, Nº 51378399820258217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 28-08-2025).*
>
> *EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RIBOCICLIBE. NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO EVIDENCIADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I - Denota-se a motivação do acórdão embargado, no sentido do litisconsórcio passivo necessário com a União, haja vista a modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF, quanto ao deslocamento de competência das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos através do Sistema Único de Saúde (item I), e a vigência para as ações propostas a partir da publicação da Ata de Julgamento do RE nº 1.366.243 (19.09.2024), a indicar a incidência dos efeitos da medida cautelar referendada no Plenário do STF - TPI-Ref-RE nº 1.366.243 -, para as ações ajuizadas até o referido marco. II - Assim, conforme os critérios estabelecidos no e. STF na tutela provisória incidental, e a padronização do medicamento Ribociclibe no Sistema Único de Saúde, por meio da Portaria SCTIE/MS nº 73/2021 do CONITEC, devida a emenda da inicial, para fins da inclusão da União no polo passivo, consoante item 5.1 do aresto referido. III - Assim, não demonstrada a omissão e contradição alegadas, a indicar a nítida pretensão de rediscussão da matéria, incabível na via aclaratória. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.(Agravo de Instrumento, Nº 52362796620248217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-08-2025)*

Pela prova judicializada, o custo anual do tratamento buscado é de R$ 204.739,92 (1.18), montante inferior ao limite dos 210 salários mínimos estabelecidos para conhecer da competência deste juízo para apreciar o tema e não remeter o processo para apreciação para a Justiça Federal.

Quanto à necessidade do uso do fármaco pela parte autora, além dos documentos médicos apresentados com a inicial (1.10; 1.11), temos o parecer técnico com conclusão favorável a utilização do medicamento para tratamento da doença (evento 5.1), nos seguintes termos:

Evidências e resultados esperados

Tecnologia: SUCCINATO DE RIBOCICLIBE

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: O câncer de mama é a neoplasia mais comum entre as mulheres, representando cerca de 30% de todos os casos de câncer no Brasil1 . Uma vez metastático é considerado incurável, mas altamente tratavel com quimioterapia. hormonioterapia, imunoterapia e drogas-alvo. As drogas inibidoras de ciclinas (CDK 4/6) são drogas orais novas, com ação em câncer de mama metastático e com expressão de receptors hormonais (receptor de estrogenio). As atualmente disponíveis no mercado são o palbociclibe2, 3, ribociclibe4 e abemaciclibe5, 6. A pesar de diferentes entre si e da ausência de estudos comparativos entre estas 3 drogas, elas são consideradas, em geral equivalenes

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: O estudo MONALESSA-7 descreve que pacientes que fizeram uso de RIBOCICLIBE tiveram redução de risco de morte de cerca de 30%, quando comparado ao braço controle.

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Recomendada

Conclusão

Tecnologia: SUCCINATO DE RIBOCICLIBE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de neoplasia maligna de mama metastática, positiva para receptores de hormonais, negativa para HER-2.
CONSIDERANDO indicação do tratamento em 1ª linha.
CONSIDERANDO a evidência robusta do benefício do ribociclibe na situação acima.
CONCLUI-SE que HÁ elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação de ribociclibe no presente caso.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco potencial de vida

Dado o contexto retratado nos autos, aliado aos precedentes jurisprudenciais apresentados, o indeferimento administrativo de fornecimento do fármaco à parte autora se mostra indevido, configurando omissão estatal que justifica a intervenção judicial para acolher a pretensão.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **GISELE DE FÁTIMA AGUIAR PEIXOTO** em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, para:

a) **CONFIRMAR** a tutela de urgência concedida (7.1) e **CONDENAR** o réu à obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo e ininterrupto do medicamento à base do princípio ativo **RIBOCICLIBE 200mg**, na quantidade e posologia indicadas em prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, a ser comprovada pela autora.

b) **DETERMINAR** que a continuidade do fornecimento fica condicionada à apresentação, pela parte autora, de laudo médico e receita atualizados a cada 6 (seis) meses, atestando a permanência da indicação terapêutica.

O réu é isento do pagamento das custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 14.634/2014.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEP), que fixo, em R$ 500,00, de acordo com o Tema 1.002 do STF e o artigo 85, § 8º, do CPC, por ser a causa de valor inestimável.

Registro o Tema 1313, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou a tese no sentido de que *"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC".*

Sentença não sujeita à remessa necessária, visto que o valor da causa é inferior ao limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Interposta apelação por qualquer das partes ou recurso adesivo, considerando não haver mais juízo de admissibilidade em primeiro grau, nos termos do art. 1.010, do CPC, intime-se a parte apelada para contrarrazões e, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimação eletrônica das partes agendada.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LUANA SCHNEIDER, Juíza de Direito**, em 01/10/2025, às 22:22:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10091923102v14** e o código CRC **20ab91a2**.

---

1. https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2021/20211207_relatorio_678_abemaciclibe_palbociclibe_ribociclibe_carcinoma_mama_final.pdf ↩